

Copiloto de Ficha



Manual de uso. Cómo ocupar la herramienta mientras atiende: el flujo de una consulta, los atajos, qué significan las marcas ámbar, el checkpoint antes de copiar y los cinco documentos.

Centro Médico Carampangue · ficha.agentecmc.cl

CONTENIDO

1. Qué es (y qué no es)
2. El flujo de una consulta
3. El copiloto: lo que aparece a la derecha
4. Las marcas ámbar: frases sin respaldo
5. El checkpoint antes de copiar
6. Los cinco documentos
7. La Constancia GES en detalle
8. Cómo aprende su forma de escribir
9. Atajos de teclado
10. Lo que la herramienta NO hace

01 Qué es (y qué no es)

Es un **borrador de trabajo**. Usted escribe o dicta desordenado, la herramienta ordena, revisa y arma los documentos, y **usted copia el texto a Medilink**. La ficha oficial sigue siendo la de Medilink.

Se autoborra a los 7 días

Las fichas de acá son transitorias. A los 7 días desaparecen del archivo, de verdad (no quedan restos legibles). El registro que dura es el de Medilink.

El dictado no sale de su computador

Se transcribe localmente. El audio se borra apenas se transcribe. En el servidor el dictado está apagado: sólo funciona en su equipo.

La IA redacta, usted firma

Nunca completa una dosis que usted no dijo.
Nunca recomienda conducta en una urgencia: avisa y se detiene. No diagnostica, no indica, no decide.

La regla de oro

Todo lo que sale de la IA es un **borrador**. Nada se entrega ni se pega sin que usted lo lea. La herramienta está construida para que revisar sea rápido — no para que revisar sea opcional.

02 El flujo de una consulta

- 1 Identifique al paciente.** Nombre, RUT y edad. Si el paciente ya vino esta semana, aparecen sus fichas previas para no volver a preguntar los antecedentes. Si activa el consentimiento verbal, se agrega la línea correspondiente al texto que se copia a Medilink.
- 2 Escriba o dicte.** Puede tipear directo en cada sección, usar las frases rápidas (los atajos de siempre: "Niega alergias", "CSV normales", "IRA alta"...) o dictar con  en la sección donde está parado.
- 3 Ordene con IA** si escribió a chorro. La IA reparte lo que usted dijo en las secciones de la ficha. **No agrega nada:** sólo mueve y redacta lo que ya estaba. La ficha se va llenando a medida que el modelo escribe.
- 4 Mire el panel de la derecha** mientras atiende: banderas rojas, GES, qué falta preguntar, qué escala corresponde.
- 5 Revise lo que la herramienta le marcó** (§4 y §5) y recién ahí **copie la ficha** a Medilink.
- 6 Emita los documentos** que el paciente se lleva (§6).

03 El copiloto: lo que aparece a la derecha

El panel de la derecha se llena solo mientras usted escribe. Está ordenado por lo que **importa primero**: arriba lo que puede matar o lo que es una obligación legal; abajo lo que ayuda.

Copiloto de Ficha

Maria Pérez González 12.345.678-5 · 54 años

Guardado 02:54 a. m.

Inicio

Buscar 🔍

ANAMNESIS

MOTIVO DE CONSULTA

Poliuria, polidipsia y baja de peso.

ENFERMEDAD ACTUAL

Refiere poliuria, polidipsia y baja de peso de 2 meses. Glicemia en ayunas 186 mg/dL en dos tomas. Sin cetosis, sin compromiso del estado general.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES MÓRBIDOS

Sin antecedentes mórbidos previos.

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS

ANTECEDENTES FAMILIARES

SEGURIDAD CLÍNICA

POSIBLE GES

Diabetes Mellitus tipo 2 - GES 7

Garantía: Confirmación diagnóstica ≤45 días desde derivación desde APS; Inicio de tratamiento ≤45 días desde confirmación diagnóstica

Cuadro clínico compatible (poliuria, polidipsia, baja de peso) + glicemia en ayunas ≥126 mg/dL en dos ocasiones. Califica para garantías GES de acceso y oportunidad.

Emitir constancia GES

QUÉ FALTA PREGUNTAR

- HbA1c para confirmar diagnóstico (criterio diagnóstico formal).
- Perfil lipídico y función renal (creatinina, TFG) para evaluación de complicaciones basales.
- Examen físico dirigido: presión arterial, peso/IMC, búsqueda de signos de neuropatía o retinopatía.
- Antecedentes familiares de diabetes, HTA, dislipidemia o enfermedad cardiovascular.
- Hábitos: tabaquismo, alcohol, actividad física,

Consulta real: el copiloto reconoció el cuadro (poliuria, polidipsia, baja de peso, glicemia 186 en dos tomas), lo marcó como **GES 7 — Diabetes Mellitus tipo 2**, mostró la garantía con sus plazos y ofrece emitir la constancia. A la derecha, lo que falta preguntar.

BLOQUE	QUÉ ES	QUÉ HACER
BANDERA ROJA	Un hallazgo de alarma. Dice qué hay que descartar; no le dice qué hacer — la conducta la decide usted.	Vaya a la siguiente con   F y márkela revisada con   A .
POSIBLE GES	El cuadro calza con una patología del catálogo GES (103 patologías). Trae el número, la garantía y el plazo.	Si corresponde, emita la constancia desde ahí mismo (§7).
Qué falta preguntar	Lo que ese motivo de consulta obliga a preguntar o descartar, y lo que aún no está escrito.	Pregúntelo, o ignórelo si no aplica. Es una sugerencia.

Escalas

El score que corresponde al cuadro (CURB-65, HEART, Centor, PHQ-9...).

Ábrala, marque los ítems y el resultado se inserta redactado en la ficha.

Si dice "Actualizando — no lo tome como vigente"

Significa que usted siguió escribiendo y el panel todavía refleja el texto anterior. Espere un segundo: prefiere avisarle que está desactualizado antes que mostrarle algo viejo como si fuera actual.

04 Las marcas ámbar: frases sin respaldo

Es la parte más importante del manual.

Cuando la IA ordena la ficha, **cada frase queda amarrada al pedazo de lo que se dijo del que salió**. Si una frase **no** tiene de dónde agarrarse — es decir, la IA la escribió pero **nadie la dijo** — se pinta en **ÁMBAR**.

Ámbar = esa frase no está respaldada por lo que se dijo en la consulta.

Puede ser inofensivo (la IA redondeó una redacción) o puede ser grave (se inventó un hallazgo, una dosis o un antecedente). **No hay forma de saberlo sin leerla.** Por eso se marca en vez de esconderse.

Copiloto de Ficha

Juan Pérez Soto 12345678-5 · 54 años

Guardado 02:32 a. m.

Inicio

Buscar

⌂

?

HÁBITOS (TABACO / OH / DROGAS)

Fuma 10 cigarrillos al día desde los 20 años.

1 FRASE CON FUENTE

EXAMEN

REVISIÓN POR SISTEMAS

EXAMEN FÍSICO

Presión arterial 150/90 mmHg, frecuencia cardíaca 78 latidos por minuto. Abdomen blando, depresible, indoloro, sin visceromegalia.

1 SIN RESPALDO EN LO QUE SE DIJO — VERIFIQUELA

CIERRE

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

PLAN E INDICACIONES

Se solicita electrocardiograma. Se indica ácido acetilsalicílico 100 mg al día por 30 días.

1 SIN RESPALDO EN LO QUE SE DIJO — VERIFIQUELA

Copiar ficha · 6 por revisar

Documentos

Escalas

Ordenar texto con IA

Nueva ficha

SEGURIDAD CLÍNICA

POSIBLE GES

Infarto agudo del miocardio · GES 3

Garantía: Reperusión oportuna ≤90 minutos desde ingreso al servicio; tratamiento post-IAM ≤30 días desde alta hospitalaria

Dolor torácico opresivo con esfuerzo, HTA, tabaquismo. Aunque aún no confirmado, el cuadro es compatible con SCA y obliga a descartar IAM como urgencia.

CRÍTICO

Dolor torácico opresivo con esfuerzo (caminar) → descartar síndrome coronario agudo (SCA). ECG precoz obligatorio.

Marcar revisada

CRÍTICO

Factores de riesgo CV presentes: HTA.

TRAZABILIDAD

Haga clic en una frase de la ficha para ver de dónde salió.

2 SIN RESPALDO

Abdomen blando, depresible, indoloro, sin visceromegalia.

Se indica ácido acetilsalicílico 100 mg al día por 30 días.

Verificar contra lo que se dijo

SEGUNDA PASADA

Sin respaldo · mayor

Abdomen blando, depresible, indoloro, sin visceromegalia.

El examen abdominal no aparece en la fuente. Solo se reportan PA y FC. · en Examen físico

Marcar revisada

Frases sin respaldo marcadas en la ficha, y el verificador de segunda pasada trabajando sobre la nota.

El verificador (⌘ ⇧ V)

Audita la nota contra lo que se dijo, en **las dos direcciones**. Es la diferencia entre revisar y crear:

Alucinación

Está en la nota, pero nadie lo dijo. Ejemplo real: la nota decía "Metformina 850 mg cada 12 horas por 30 días" y en la consulta sólo se dijo "vamos a iniciar metformina". La dosis **la inventó la máquina**.

Omisión

Se dijo, pero no llegó a la nota. Ejemplo real: el paciente dijo "soy alérgico a la penicilina" y la ficha quedó con "Niega alergias conocidas". **Es el error más frecuente**, y el más peligroso.

Los dos ejemplos de arriba no son hipotéticos.

Son la prueba de sabotaje que se corre contra la herramienta: se le mete una posología inventada y una alergia omitida, y el verificador tiene que cazar las dos. Hoy las caza — en producción.

05 El checkpoint antes de copiar

El botón de copiar no dice sólo "Copiar ficha": dice **cuántos puntos quedan por revisar**. Y si quedan, antes de copiar le muestra cuáles son.


Copiloto de Ficha

Juan Pérez Soto 12.345.678 - 9 · 54 años

● Cambios sin guardar...

Inicio

Buscar 





EXAMEN FÍSICO

PA 158/95 mmHg, FC 102 lpm, FR 22 rpm, SatO2 94% ambiental. Pálido, sudoroso. Ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos.

CIERRE

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Síndrome coronario agudo a descartar.

PLAN E INDICACIONES

ECG en 10 minutos. Vía venosa. AAS 300 mg. Traslado a urgencia.

Copiar ficha · 5 por revisar

Documentos

Escalas

Ordenar texto con IA

Nueva ficha


5 puntos por revisar antes de copiar a Medilink: DOLOR TORÁCICO TÍPICO + FACTORES DE RIESGO CV: Descartar SCA/IAM. ECG inmediato. Troponina. Derivar a unidad coronaria. · Taquicardia (FC 102) + taquipnea (FR 22) + disnea: Evaluar insuficiencia cardíaca aguda o complicación mecánica. · PA elevada (158/95) + sudoración + palidez: Signos de estrés simpático. Monitoreo continuo. · SatO2 94% con disnea leve: Vigilar deterioro respiratorio. Oxígeno si cae <92%. · Ventana terapéutica crítica: Si IAM confirmado, reperfusión (fibrinólisis o angioplastia) debe iniciarse <90 min desde ingreso.

Revisar

Copiar igual


SEGURIDAD CLÍNICA


POSIBLE GES

Infarto agudo del miocardio · GES 3

Garantía: Reperusión oportuna ≤90 minutos desde ingreso al servicio; Tratamiento post-IAM ≤30 días desde alta hospitalaria

Dolor torácico retroesternal opresivo de 2h, irradiado a brazo izquierdo y mandíbula, con sudoración, náuseas, disnea, en varón 54a con HTA, dislipidemia y tabaquismo activo. Signos vitales: PA elevada, taquicardia, taquipnea. Cuadro clínico altamente sugestivo de SCA/IAM.


CRÍTICO

DOLOR TORÁCICO TÍPICO + FACTORES DE RIESGO CV: Descartar SCA/IAM. ECG

QUÉ FALTA PREGUNTAR

- ⌚ ECG de 12 derivaciones **URGENTE** (debe estar hecho ya en box/urgencia, <10 min desde llegada).
- ⌚ Troponina de alta sensibilidad (serial si primera es negativa).
- ⌚ Caracterización del dolor: ¿duración exacta del episodio?, ¿cambios con movimiento o respiración?, ¿factores desencadenantes?
- ⌚ Antecedentes familiares de enfermedad coronaria precoz.
- ⌚ Medicamentos actuales (dosis de antihipertensivos, estatinas, antiagregantes).

El checkpoint: enumera las banderas rojas sin revisar, las alucinaciones, las omisiones y las frases sin respaldo. Puede ir a revisarlas o copiar igual.

Cuenta cuatro cosas: banderas rojas que no ha marcado como revisadas, alucinaciones, omisiones y frases sin respaldo.

"Copiar igual" existe a propósito.

Usted manda. La herramienta **no** le bloquea el paso: le pone el dato adelante en el único momento en que todavía es barato arreglarlo — antes de que el texto entre a la ficha oficial.

06 Los cinco documentos

Se abren con el botón **Documentos** o desde la paleta ( **K**). Todos se llenan solos con lo que usted ya escribió en la ficha: no se vuelve a tipear nada.

DOCUMENTO	PARA QUÉ	OJO CON
Orden de exámenes	Los exámenes marcados, con la sospecha diagnóstica. Tiene buscador.	—
Interconsulta	La derivación al especialista. La IA la redacta desde la ficha.	Tiene checklist: le avisa qué falta para que no se la rechacen.
Indicaciones al paciente	El plan traducido a lenguaje simple, para que se lo lleve.	Revíselo: es lo que el paciente va a leer en su casa.
Certificado de reposo	Constancia de atención y reposo.	No reemplaza la licencia médica (LME) , y el documento lo dice.
Constancia GES	La notificación al paciente. Es una obligación legal.	Formato oficial, 2 ejemplares. Ver §7.

El checklist de la interconsulta

Las interconsultas a la red pública **se rechazan por antecedentes incompletos**. El rechazo llega semanas después, y el que lo paga es el paciente, que se quedó sin hora y sin que nadie le avisara. Por eso el aviso llega **antes** de emitir.



ANAMNESIS

MOTIVO DE CONSULTA

Poliuria, polidipsia

ENFERMEDAD ACTUAL

Refiere poliuria, cetosis, sin com

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES MÓR

Sin antecedente

ANTECEDENTES QUIR

ANTECEDENTES FAMILIARES

Interconsulta



ESPECIALIDAD

Cardiología

HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA

Diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico.

MOTIVO DE LA DERIVACIÓN

RESUMEN DEL CUADRO

Previsualizar

Descargar PDF

Word

Imprimir

Cerrar

GES 7

agnóstica ≤45 días
PS; Inicio de
e confirmación(poliuria, polidipsia,
n ayunas ≥126 mg/dL
para garantías GES

nóstico (criterio

al (creatinina, TFG)
caciones basales.sión arterial,
gnos de neuropatía o○ Antecedentes familiares de diabetes, HTA,
dislipidemia o enfermedad cardiovascular.○ Hábitos: tabaquismo, alcohol, actividad física,
dieta

El checklist muestra cuántos campos faltan de los 9 exigidos y, en cada uno, **por qué** se pide. Avisa; no bloquea.

07 La Constancia GES en detalle

Esto no le ahorra tiempo: le baja riesgo médico-legal.

Informar al paciente que tiene derecho a las GES es una **obligación del prestador** (art. 24 de la Ley 19.966 y DS 136/2005). No hacerlo se sanciona con amonestación o **suspensión de hasta 180 días** para otorgar GES.

Se emite desde el flag, ya pre-llenada

Cuando el copiloto detecta una patología GES, el botón **Emitir constancia GES** aparece en el mismo panel. Al abrirlo, la patología, el número GES y la garantía ya vienen puestos.

Copiloto de Ficha

Maria Pérez González12.345.678-5 · 54 años

Guardado 02:54 a. m.

Inicio

Buscar

ANAMNESIS

MOTIVO DE CONSULTA

Poliuria, polidipsia

ENFERMEDAD ACTUAL

Refiere poliuria, cetosis, sin com

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES MÓR

Sin antecedente

ANTECEDENTES QUIR

ANTECEDENTES FAMILIARES

Constancia GES

Obligación legal del prestador (art. 24 Ley 19.966; DS 136/2005). Desde la Circular IF/469 (2024): las patologías GES NO oncológicas se notifican en la CONFIRMACIÓN (es la única casilla del formulario), y las oncológicas llevan un formulario por cada hito. Un formulario = un problema de salud. El formato es oficial y no puede alterarse: por eso este documento no lleva la marca del CMC.

PROBLEMA DE SALUD GES

Diabetes Mellitus tipo 2

CÓDIGO GES

GES 7

GARANTÍA Y PLAZO (VA EN HOJA APARTE)

Confirmación diagnóstica ≤45 días desde derivación desde APS; Inicio de tratamiento ≤45 días desde confirmación

☐ Es una patología ONCOLÓGICA

PREVISIÓN

FONASA

Previsualizar

Descargar PDF (2 ejemplares)

Imprimir

Cerrar

La constancia llega pre-llenada desde lo que el copiloto detectó. Usted completa sólo lo que la norma exige y que únicamente usted sabe: previsión, domicilio, comuna, región, teléfono y correo.

Copiloto de Ficha

Maria Pérez González12.345.678-5 · 54 años

Guardado 02:54 a. m.

Inicio

Buscar

ANAMNESIS

MOTIVO DE CONSULTA

ENFERMEDAD ACTUAL

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES MÓR

ANTECEDENTES QUIR

ANTECEDENTES FAMILIARES

Constancia GES

✓ Completo — están los 12 campos que se exigen

Formulario de constancia información paciente GES

(Artículo 24º, Ley 19.966)

Se emitirán 2 ejemplares: EJEMPLAR PARA EL PACIENTE / EJEMPLAR PARA EL PRESTADOR

DATOS DEL PRESTADOR

INSTITUCIÓN (HOSPITAL, CLÍNICA, CONSULTORIO, ETC.)

Centro Médico Carampangue

DIRECCIÓN

Carampangue, Región del Biobío, Chile

CIUDAD

Carampangue

NOMBRE PERSONA QUE NOTIFICA

Dr. Rodrigo Olavarría

RUN

15.111.222-3

ANTECEDENTES DEL PACIENTE

NOMBRE LEGAL

Maria Pérez González

NOMBRE SOCIAL

Previsualizar

Descargar PDF (2 ejemplares)

Imprimir

Cerrar

GES 7

agnóstica ≤45 días

PS; Inicio de

e confirmación

(poliuria, polidipsia,

n ayunas ≥126 mg/dL

para garantías GES

ónstico (criterio

al (creatinina, TFG)

caciones basales.

sión arterial,

gnos de neuropatía o

Antecedentes familiares de diabetes, HTA,

dislipidemia o enfermedad cardiovascular.

Hábitos: tabaquismo, alcohol, actividad física,

dieta

El checklist confirma que están los 12 campos exigidos, y abajo se previsualiza el formulario oficial tal como se va a imprimir.

Dos cosas que suelen entenderse al revés

Se notifica en la CONFIRMACIÓN, no en la sospecha

Desde la Circular IF/469 (2024), en las patologías GES **no oncológicas** la única casilla que existe en el formulario es **Confirmación**. La cobertura puede partir en la sospecha, pero **la notificación se marca como confirmación**.

Las oncológicas llevan un formulario por hito

Sospecha, confirmación, etapificación, tratamiento, seguimiento y rehabilitación: **uno por cada hito**, para dejar trazabilidad del derecho al olvido oncológico. Y siempre **un formulario = un problema de salud**.

¿Por qué este documento no lleva el logo del CMC, si los otros cuatro sí?

Porque la norma lo prohíbe. El Compendio de la Superintendencia dice, literal, que "*el formato del Formulario no podrá ser alterado ni contener distintivos del prestador*". Ponerle la marca sería incumplir la misma norma que el documento existe para cumplir. Por lo mismo **no se ofrece en Word**: un archivo editable es una invitación a alterarlo.

Formulario de constancia información paciente GES

(Artículo 24°, Ley 19.966)

DATOS DEL PRESTADOR	
INSTITUCIÓN (HOSPITAL, CLÍNICA, CONSULTORIO, ETC.) Centro Médico Carampangue	
DIRECCIÓN Carampangue, Región del Biobío, Chile	CIUDAD Carampangue
NOMBRE PERSONA QUE NOTIFICA Dr. Rodrigo Olavarria	RUN 15.111.222-3
ANTECEDENTES DEL PACIENTE	
NOMBRE LEGAL María Pérez González	NOMBRE SOCIAL
RUN 12.345.678-5	PREVISIÓN
☒ FONASA	☐ ISAPRE
DOMICILIO Los Aromos 123	
COMUNA Arauco	REGIÓN Biobío
N° TELÉFONO +56 9 1234 5678	CORREO ELECTRÓNICO maria.perez@correo.cl
INFORMACIÓN MÉDICA	
PROBLEMA DE SALUD GES Diabetes Mellitus tipo 2 · GES 7	
☒ Confirmación	
PROBLEMA DE SALUD GES ONCOLÓGICO	
☐ Sospecha	☐ Confirmación
☐ Tratamiento	☐ Seguimiento
	☐ Etapificación
	☐ Rehabilitación
TIPO ATENCIÓN	
☒ Presencial	☐ Teleconsulta
CONSTANCIA	
Tomo conocimiento que tengo derecho a acceder a las Garantías Explícitas en Salud, en la medida que me atienda en la red de Prestadores que asigne el Fonasa o la Isapre, según corresponda.	
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN 12-07-2026 02:56 h	

INFORMÉ PROBLEMA SALUD GES
(Firma de persona que notifica)

TOMÉ CONOCIMIENTO
(Firma o huella dactilar del paciente o representante)

En la modalidad de TELECONSULTA, en ausencia de la firma o huella, se registrará el medio a través del cual el/la paciente o su representante tomó conocimiento:

☐ Correo electrónico

☐ Carta certificada

☐ Otros:

SI QUIEN TOMÓ CONOCIMIENTO NO ES EL PACIENTE, IDENTIFICAR AL REPRESENTANTE

NOMBRE	RUN
N° TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

IMPORTANTE: Tenga presente que si no se cumplen las garantías usted puede reclamar ante Fonasa o la Isapre, según corresponda. Si la respuesta no es satisfactoria, usted puede recurrir en segunda instancia a la Superintendencia de Salud.

El formulario oficial como sale impreso: datos del prestador, del paciente, problema de salud GES, casilla de confirmación, tipo de atención, la leyenda legal, **la fecha y la hora**, y los dos espacios de firma (el suyo y el

del paciente). Se emiten **2 ejemplares**: uno para el paciente y uno para la ficha.

Además, si escribió la garantía, se agrega una **hoja aparte** para el paciente, rotulada como tal, con el plazo por escrito. No forma parte del formulario oficial — justamente para no alterarlo.

HOJA INFORMATIVA PARA EL PACIENTE

No forma parte del formulario oficial GES. Se entrega aparte para que usted tenga por escrito el plazo de su garantía.

PROBLEMA DE SALUD GES

Diabetes Mellitus tipo 2 · GES 7

GARANTÍA Y PLAZO

Confirmación diagnóstica ≤45 días; inicio de tratamiento ≤45 días desde la confirmación

Para hacer efectivas sus garantías debe atenderse en la red de prestadores que le asigne Fonasa o su Isapre. Lleve el ejemplar firmado de la constancia. Si no se cumplen los plazos, puede reclamar ante Fonasa o su Isapre.

Centro Médico Carampangue · Carampangue, Región del Biobío, Chile
Tel. (44) 296 5226 · WhatsApp +56 9 6661 0737 · centromedicocarampangue.cl

Hoja informativa opcional para el paciente, con la garantía y su plazo. Va separada del formulario oficial y lo dice explícitamente.

La app emite la constancia, pero NO la archiva.

La norma exige conservar el ejemplar firmado **15 años**. Esta herramienta no guarda documentos, y la ficha se autoborra a los 7 días. **El ejemplar firmado hay que archivarlo fuera de acá** — en papel o en Medilink. No asuma que el sistema lo guarda: no lo guarda.

08 Cómo aprende su forma de escribir

Ningún producto grande del rubro hace esto: Heidi y Abridge declaran explícitamente que **no** tienen aprendizaje adaptativo. Con un solo médico, sí se puede.

Cada vez que usted **ordena con IA** y después **copia la ficha**, la herramienta compara las dos versiones: la que propuso la IA y la que usted finalmente dejó. Esa diferencia es la única señal que dice cómo escribe usted. Cada **20 notas**, esas diferencias se destilan en **reglas de estilo** que se inyectan en el prompt, para que el próximo borrador salga más parecido a lo suyo.

Copiloto de Ficha | María Pérez González | 12.345.678-5 · 54 años | Guardado 02:54 a. m. | Inicio | Buscar | K | ?

Esto aprendí de su forma de escribir [X]

Estas reglas salen de comparar el borrador que le propuso la IA con la nota que usted finalmente dejó. Se inyectan al **Ordenar con IA** para que el borrador salga cada vez más parecido a como escribe usted. **Nunca pueden pasar por encima de las salvaguardas** (posología, urgencias). Los textos de sus pacientes **no se guardan**: se procesan y se borran.

No completa la sección Revisión por sistemas; la deja vacía en lugar de escribir 'sin hallazgos relevantes'. (vacío) (no: Revisión por sistemas sin hallazgos relevantes.)	Borrar
Elimina descripciones genéricas de estado general ('Se observa buen estado general') de Enfermedad actual. Refiere dolor abdominal de 3 días. (no: ...Se observa buen estado general.)	Borrar
Usa 'Refiere' en lugar de 'El paciente relata' al inicio de Enfermedad actual. Refiere dolor abdominal... (no: El paciente relata dolor abdominal...)	Borrar

0 nota(s) acumuladas hacia la próxima destilación (cada 20).

Olvidar todo

La pantalla “Esto aprendí de su forma de escribir” (en la paleta, **K**). Cada regla se puede borrar. Estas tres salieron de un ciclo real de destilación.

Usted las ve y las borra

No es una caja negra. Si aprendió algo mal, lo borra y deja de usarse desde la siguiente vez. También puede olvidar todo de una.

Nunca pasa sobre las salvaguardas

Ninguna regla de estilo puede autorizar a inventar una dosis ni a recomendar conducta en una urgencia. Ante conflicto, mandan las salvaguardas.

El texto de sus pacientes no se acumula

Lo que se compara es dato clínico: vive 7 días como la ficha, se borra con ella y **se destruye al destilarse**. Lo que queda es la regla, que es estilo — no dato de paciente.

09 Atajos de teclado

El que hay que aprenderse es uno: **⌘ K**. Desde ahí se llega a todo — secciones, frases rápidas, escalas, documentos y acciones — escribiendo dos letras.

ATAJO	QUÉ HACE
⌘ K	Paleta de comandos. Busca cualquier cosa: una sección, una frase, una escala, un documento, el estilo aprendido.
⌘ 1 ... ⌘ 9	Saltar directo a una sección de la ficha.
⌘ D	Dictar en la sección donde está parado (sólo en su computador).
⌘ ⇧ F	Ir a la próxima bandera roja.
⌘ ⇧ A	Marcar la bandera como revisada.
⌘ ⇧ V	Verificar la ficha contra lo que se dijo.
?	Ver todos los atajos.

10 Lo que la herramienta NO hace

Dicho claro, para que no haya sorpresas atendiendo:

NO HACE	POR QUÉ
No completa posología. Si usted no dijo la dosis, no la inventa.	Es donde los modelos fallan peor: cambiar "semanal" por "diario" le cuesta casi nada al modelo y le cuesta mucho al paciente. La dosis la escribe usted.
No recomienda conducta en una urgencia. Avisa y se detiene.	Bajo presión de tiempo nadie alcanza a revisar de forma independiente lo que el software propone. Ahí el software deja de ser ayuda y pasa a ser riesgo.
No completa el examen físico. Si no se examinó, no se escribe.	Un examen "normal" que nadie hizo es un hallazgo falso en la ficha.
No firma, no diagnostica, no decide.	Redacta borradores. El médico es usted.
No reemplaza a Medilink ni guarda el registro oficial.	Es un borrador transitorio. Se autoborra a los 7 días.
No archiva la Constancia GES firmada.	La norma pide guardarla 15 años. Eso se hace fuera de acá (\$7).

Copiloto de Ficha · Centro Médico Carampangue · ficha.agentecmc.cl

Herramienta de apoyo a la documentación clínica. Los documentos que emite los revisa y los firma el médico tratante.

Teléfono (44) 296 5226 · WhatsApp +56 9 6661 0737 · centromedicocarampangue.cl